

Obstrução intestinal - diagnóstico e conduta

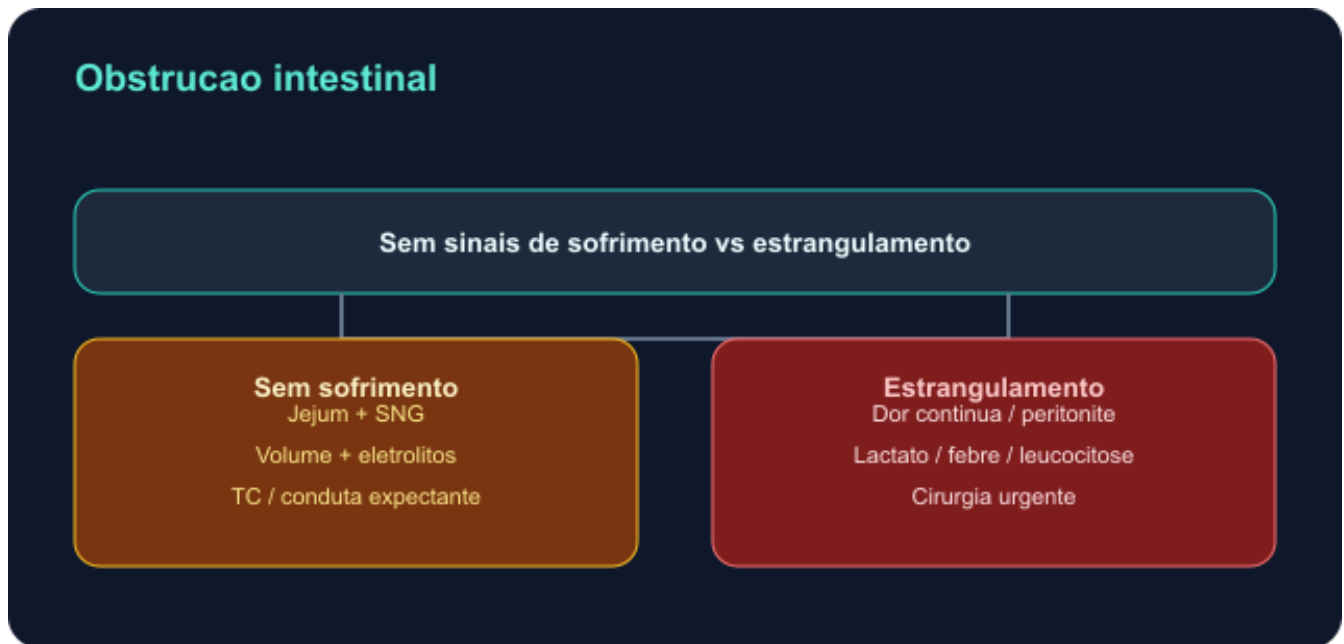
Obstrução = parada ou lentificação do trânsito com dor, distensão, vômitos e parada de eliminação. Diferencie mecânica de íleo parálítico e procure sinais de isquemia/estrangulamento.

Causas clássicas

Lembre - Causas clássicas

Delgado: bridas/aderências, hérnias, tumores. Cólon: câncer, volvo, diverticulite. Íleo: pós-op, eletrólitos, fármacos, sepse abdominal.

Ramificação: estável sem peritonite !' reanimação + sonda + TC; sofrimento/peritonite !' cirurgia.



Avaliação

- Exame: cicatrizes, hérnias, ruídos metálicos vs silêncio, peritonite
- Lab: leucócitos, lactato, eletrólitos, função renal
- Rx: níveis hidroaéreos; TC com contraste define transição e complicações
- Reanimação: volume, correção de K z/Mg² z, decompressão com SNG

Sinais de estrangulamento

Achado | Conduta

Dor contínua + defesa | Cirurgia sem demora

Febre / taquicardia / leucocitose | Suspeitar isquemia

Lactato elevado / acidose | Sala + reanimação

Pneumoperitônio | Perfuração — laparotomia

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Íleo parálítico não se opera 'por imagem de dilatação' isolada — trate causa. Já a obstrução mecânica com sinais de sofrimento intestinal não fica só na sonda nasogástrica.